PROGRAMME DE SUIVI PRÉCLINIQUE

Protéger le présent, préparer l'avenir

Programme de suivi pour les porteurs asymptomatiques de mutations du gène de la protéine prionique

Disposer d'informations sur sa génétique est un acte de courage. Ce site est pensé pour vous accompagner : vous expliquer ce que signifie être porteur ou porteuse, pourquoi un suivi régulier est un outil efficace, et quelles possibilités offre le futur proche

01

Comprendre votre point de départ

Ce que signifie être porteur ou porteuse

Vous êtes porteur ou porteuse d'une variante génétique (aussi appelée mutation – un changement de l'ADN par rapport à la majorité de la population) qui peut être associée au développement d'une maladie à prions héréditaire. Cela signifie qu'il existe un risque accru, pas une certitude. De nombreuses personnes ayant cette prédisposition génétique vivent des décennies sans développer aucun symptôme, et la science progresse à vive allure vers des traitements préventifs.

Être porteur ou porteuse n'est pas la même chose qu'avoir la maladie. C'est une prédisposition qui vous fournit des informations précieuses — et ces informations peuvent, bien utilisées, se transformer en un réel avantage.

- **Tous les porteurs ne développent pas de symptômes.** La pénétrance — c'est-à-dire la probabilité que la mutation finisse par déclencher la maladie — est élevée, bien que l'âge d'apparition varie considérablement selon la mutation spécifique et d'autres facteurs individuels que nous ne connaissons pas encore.

- **Savoir, c'est pouvoir.** Connaître votre statut génétique vous permet de prendre des décisions éclairées, de planifier l'avenir et d'accéder à des programmes de suivi spécialisés.

- **La science ne s'arrête pas.** Il n'y a jamais eu autant de recherche active sur les maladies à prions qu'aujourd'hui. Nous nous trouvons à un moment décisif pour le développement de thérapies préventives.

02

Pourquoi le suivi est important

Quatre raisons de participer à un programme de suivi préclinique

Les programmes de suivi pour porteurs asymptomatiques ne sont pas seulement un outil de recherche et de surveillance médicale. Ce sont une plateforme de préparation active — pour vous et pour toutes les personnes qui viendront après vous – face aux thérapies préventives en développement.

Détection précoce

Détection précoce : si de subtils changements biologiques devaient apparaître, ils seraient repérés au moment le plus favorable (avant l'apparition des symptômes) pour pouvoir intervenir avec les moyens disponibles.

Accès prioritaire

Accès prioritaire : les participants aux programmes de suivi seraient les mieux placés pour accéder à de nouvelles thérapies préventives lorsque les essais cliniques ouvriront leurs portes, car on disposerait de plus d'informations que sur d'autres porteurs.

Informations réelles

Le suivi régulier fournit des données objectives sur la santé de votre cerveau et remplace l'incertitude par une connaissance fondée. Ce sont des informations auxquelles vous pouvez accéder ou que vous pouvez encore ne pas vouloir connaître.

Contribution collective

Votre participation aide à mieux comprendre la maladie et accélère le développement de traitements pour vous et pour les générations futures.

03

Deux réalités au sein d'un même profil

Tous les porteurs asymptomatiques ne se trouvent pas au même moment

Au sein du groupe des porteurs asymptomatiques, la recherche actuelle permet d'identifier deux situations clairement distinctes, même si dans les deux cas la personne ne présente pas de symptômes cliniques :

Porteur/porteuse en phase inactive

Le processus biologique associé à la mutation ne montre aucun signe d'activité détectable avec les techniques actuelles. Cela est associé à un horizon temporel plus large avant l'apparition possible des premiers symptômes.

Porteur/porteuse en phase active silencieuse

Il existe une activité biologique naissante —sans symptômes cliniques— que les techniques spécialisées peuvent commencer à détecter. Ce profil est associé à un horizon temporel plus proche, même si nous ne savons pas encore de combien ni s'il existe une grande variabilité entre porteurs, depuis la détection de l'activité biologique jusqu'au développement des premiers signes. Toutefois, ce groupe a la plus grande probabilité de pouvoir accéder aux premiers essais cliniques préventifs.

Découvrir dans laquelle de ces situations vous vous trouvez est volontaire. Le programme de suivi vous offre la possibilité de le savoir — toujours avec accompagnement et sans pression.

04

Ce qui se profile à l'horizon

Thérapies en développement et premiers essais cliniques

Il n'y a jamais eu autant de stratégies thérapeutiques actives simultanément pour les maladies à prions. Plusieurs ont déjà montré des résultats prometteurs dans des modèles animaux, et certaines ont commencé à faire le saut vers des essais chez l'humain. Cela ne garantit pas qu'elles fonctionnent toutes chez l'humain, mais cela marque un tournant historique : pour la première fois, il existe plusieurs voies réelles qui travaillent en parallèle vers de futurs traitements préventifs et modificateurs de la maladie.

CE QUE SIGNIFIE CHAQUE SITUATION

Essai clinique en cours

Il est déjà testé chez l'humain.

Essai clinique enregistré, début en attente

L'essai est défini et approuvé/enregistré, mais n'a pas encore commencé le recrutement ou le traitement.

Développement préclinique

La thérapie a montré une activité en laboratoire et/ou chez l'animal, mais n'a pas encore été testée chez l'humain.

Essai clinique en cours (Phase 1/2a)

Oligonucléotides antisens (ASO)

Ce sont des molécules développées pour réduire la production de la protéine prionique. Dans des modèles animaux, la baisse de cette protéine a retardé l'apparition de la maladie et prolongé la survie. Cette stratégie est déjà évaluée dans un essai clinique international chez des personnes atteintes de maladie à prions symptomatique.

Essai clinique enregistré, début en attente (Phase 1)

Interférence par ARN (siRNA)

Ces molécules « font taire » le message génétique qui conduit à la protéine prionique. Chez l'animal, des réductions profondes et durables de cette protéine ont été obtenues, avec des effets positifs sur l'évolution de la maladie. Il existe en outre déjà un premier essai clinique de Phase 1 enregistré pour cette stratégie, bien que le recrutement n'ait pas encore commencé.

Développement préclinique

Petites molécules à administration orale

On développe des composés capables de réduire la quantité de protéine prionique que la cellule produit. Leur grand avantage potentiel est qu'ils pourraient être administrés comme de simples traitements à long terme. Les données publiées jusqu'à présent montrent des résultats prometteurs chez l'animal, mais cette voie n'est pas encore passée aux essais cliniques.

Développement préclinique

Thérapies géniques

Elles comprennent des stratégies de silençage permanent et d'édition moléculaire visant à éteindre ou réduire durablement le gène de la protéine prionique. Dans des modèles animaux, on a déjà obtenu une large réduction de la protéine et un prolongement significatif de la survie. Certains programmes progressent vers la clinique, mais se trouvent actuellement encore en phase préclinique.

Être inscrit à un programme de suivi vous place en première ligne pour participer à ces essais, s'ils se déroulent en Espagne. La fenêtre d'opportunités s'ouvre — et ceux qui sont déjà suivis auront les meilleures chances de la franchir les premiers.

05

Ce que comprend le suivi

Le protocole de visites périodiques

Le programme consiste en des visites périodiques — généralement annuelles ou semestrielles — dans un centre spécialisé. Chaque visite est conçue pour être aussi confortable et efficace que possible, toujours avec le soutien d'une équipe dédiée.

Évaluation neurologique et neuropsychologique

Examen clinique détaillé et batterie de tests cognitifs pour déterminer et surveiller votre valeur de référence individuelle.

Biomarqueurs dans le sang, le liquide céphalorachidien et la peau

Analyse de sang et, si indiqué, ponction lombaire et/ou biopsie cutanée par punch pour mesurer des protéines spécifiques qui reflètent l'état neurobiologique.

Étude du sommeil

Au moyen de la polysomnographie, nous enregistrons ce qui se passe pendant le sommeil : mouvements, respiration, activité cérébrale et comportement. Certains troubles du sommeil – en particulier ceux liés à la phase REM – peuvent se manifester de manière subtile, surtout chez les porteurs de l'Insomnie Familiale Fatale, avant que n'apparaissent les premiers symptômes.

Imagerie à haute résolution

Imagerie par résonance magnétique du cerveau, qui permet de détecter des changements structurels ou fonctionnels avant qu'ils ne soient cliniquement reconnaissables.

Soutien psychologique

Accompagnement émotionnel et orientation spécialisée, disponibles à chaque visite et accessibles entre les visites si nécessaire.

Information sur les nouveautés thérapeutiques

Mise à jour régulière sur les essais cliniques disponibles ou en préparation pour lesquels vous pourriez être éligible, avec une orientation personnalisée pour chaque occasion.